

Datos Personales							
Nombre:	ELSA ROSA MELO GOMEZ	Sexo Biológ.:	M	F. Nacimiento:	1981-01-07	Edad	44 Años, 7 Meses, Y 29 Días
Identificación:	CC - 1065127402	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Casado	Ocupación:	AMA DE CASA
Correo Electrónico:	Mtfonsecam011@gmail.Com - 1065127402			Dirección:	Conjunto Cerrado Mz A 3B		
Departamento:	CESAR		Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana
Empresa:	Particular						

Apertura psicología del 2025-09-05 08:46:32: 44 años, 7 meses, y 29 días

DATOS GENERALES

Remisión

Psiquiatría

DX principal

F331 - TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE

DX Relacionado 1

F313 - TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO DEPRESIVO PRESENTE LEVE O MODERADO

Código de consulta

890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA

Motivo de Consulta

Refiere la hija "en el año 2014 estuvo hospitalizada por episodio de alucinacion, paranoia y delirios de persecución, decia que iba a matar" "estuvo hospitalizada una semana en UNIPSAM aproximandamente hace 2 meses " "lora todo el tiempo, tiene insomnio y no quiere hablar verbalmente".

Enfermedad Actual

Paciente femenina con antecedentes de hospitalización psiquiátrica en 2014 por episodio de alucinaciones, paranoia, delirios de persecución hacia su hija y un vecino, además de ideación suicida, pensamiento delirante y juicio desviado, requiriendo hospitalización recientemente por una semana, con lenta recuperación posterior. Actualmente, desde hace aproximadamente dos meses, presenta llanto frecuente, insomnio, deambulación nocturna por la casa y alteraciones en su funcionalidad. Refiere historia de ser previamente funcional, aunque con rasgos psicorrigidos y sobreprotección familiar. Entre los factores desencadenantes recientes se identifican: f allecimiento de su bisabuela en agosto de 2023, cambio de residencia de Cúcuta a Valledupar y antecedentes de duelo no resuelto por la pérdida de un bebé hace 12 años, hecho asociado a un conflicto familiar que generó su distanciamiento con la familia.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico

Cesàrea

Traumáticos

Otro

Paraclínicos

Ecografías

Patología

Hipertensión , Síndrome De Bata Blanca.

Tóxicos

No Refiere

Medicación

Psiquiatrías (Olanzapina Tabletas 10 Mg, Valcote ER Tableta 500 Mg).

Hospitalizaciones

Si, Internada Hace 12 Años Por Preeclamsia Y Fallecimiento De La Hija Después De 1 Mes De Nacida, Estuvo En UCI 1 Mes.

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión

No Refiere

Demencia

Hermano/a

Drogadicción

No Refiere

Patológicos

Hipertensión, Diabetes.

Ansiedad

No Refiere

Alcoholismo

No Refiere

Discapacidad Intelectual

No Refiere

Otros

No Refiere

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa

La paciente cursó estudios como Auxiliar Contable, destacándose por su organización, responsabilidad y cumplimiento en las actividades académicas. Refieren que mantenía un estilo estructurado y ordenado en su proceso formativo, logró establecer y mantener buenas relaciones interpersonales, mostrando adecuadas habilidades de socialización en el contexto educativo.

Historia laboral

La paciente se desempeñó como Auxiliar Contable durante aproximadamente 15 años, ejerciendo tanto en la ciudad de Valledupar como en Cúcuta, en modalidad independiente. Durante su trayectoria laboral mostró ser responsable y organizada en sus funciones. Mantuvo relaciones interpersonales cordiales y respetuosas, aunque de manera limitada, priorizando el cumplimiento de sus responsabilidades.

Historia familiar

Actualmente la paciente reside con su esposo, el señor Alonso León Caballero (44 años), y sus tres hijos: María Teresa Fonseca (21 años), Santiago León (7 años) e Isabela León (5 años). Refieren mantener una buena relación familiar, caracterizada por apoyo mutuo y convivencia estable. Se encuentran en proceso de fortalecer la comunicación asertiva, disminuir prácticas de sobreprotección y mantener el respeto como base de la dinámica familiar.

Historia social

La paciente mantiene relaciones interpersonales limitadas, caracterizadas por el respeto y la cordialidad. Aunque su círculo social es reducido, logra establecer y sostener conversaciones adecuadas con otras personas, mostrando habilidades básicas de interacción social.

Historia socio-afectiva

La paciente presenta antecedentes de conflictos familiares y un evento significativo de duelo asociado al fallecimiento de su bebé, situación que impactó de manera profunda su esfera emocional. Estos hechos han estado acompañados de ánimo triste, alteraciones en sus áreas funcionales, episodios psicóticos y pérdida de interés por algunas actividades, lo cual ha afectado su dinámica socioafectiva y sus vínculos interpersonales.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Evaluación psicológica inicial

Se aplicó entrevista semiestructurada a la paciente y a su hija, complementada con técnica de observación directa, explorando todas las áreas funcionales (personal, familiar, social, laboral y recreativa). Durante la evaluación, la paciente únicamente refirió su nombre, sin manifestar mayor información, mostrando resistencia verbal y escasa colaboración. En la observación clínica presentó apariencia de somnolencia, ánimo triste, retraimiento y pérdida de interés en algunas actividades. Se identificaron factores de riesgo (antecedentes psicóticos, duelos no resueltos, conflictos familiares) y factores protectores (apoyo familiar y disposición al tratamiento).

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica

Intervención y Control por Psiquiatría con Dx 1. Trastorno depresivo 2. TAB Fase depresiva, medicada con (Olanzapina tabletas 10 mg, Valcote ER tableta 500 mg).

Intervención neurológica

No refiere.

Intervención neuropsicológica

No refiere.

Otras intervenciones

No refiere.

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

La paciente ingresa a consulta en compañía de su hija, la señorita María Teresa. Presenta apariencia personal adecuada, con facies somnolienta y expresión triste. Se observa actitud poco abordable, sin mantener contacto visual. Se evidencia conciencia alterada, memoria comprometida, hipoprosexia, concentración disminuida y desorientación autopsíquica y alopsíquica alterada. En el lenguaje se presenta mutismo, y en el curso del pensamiento se identifican fuga de ideas. A nivel afectivo, se aprecia hipertimia hacia el polo de la tristeza. El juicio se encuentra desviado y se observa parcial conciencia de enfermedad, con presencia de sufrimiento psicológico significativo.

Ciclos del Sueño

Alterados.

Apetito

Alterado.

Actividades de Autocuidado

Independiente con supervisión.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V):

F331 - TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE

Establecido por primera vez

No

Objeto de atención clínica

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención
Objetivo General Promover la estabilización clínica, el fortalecimiento emocional y la recuperación funcional de la paciente, mediante un abordaje integral que incluya apoyo psicológico, psicoeducación familiar y desarrollo de estrategias de afrontamiento.
Objetivos Específicos - Favorecer la adherencia al tratamiento médico-psiquiátrico mediante psicoeducación a la paciente y su familia, garantizando la continuidad del manejo farmacológico y el monitoreo de síntomas. - Fortalecer las habilidades de afrontamiento emocional de la paciente a través de técnicas de regulación afectiva, manejo del ánimo triste y prevención de recaídas. - Optimizar la dinámica sociofamiliar trabajando en la mejora de la comunicación asertiva, reducción de la sobreprotección y fortalecimiento de redes de apoyo. - Estimular la funcionalidad personal y social promoviendo la participación en actividades estructuradas, rutinas diarias y actividades gratificantes que favorezcan la reintegración progresiva a sus áreas de desempeño.
Sugerencias e Interconsultas Continuar en control con Psiquiatría.
Observaciones y Recomendaciones - Iniciar tratamiento por Psicología Individual de manera prioritaria. - Terapia familiar enfocada en disminuir la sobreprotección, mejorar la dinámica de apoyo y fortalecer la red afectiva. - Establecer rutinas diarias estructuradas, incluyendo actividades recreativas y de autocuidado que favorezcan la activación conductual y disminuyan el sedentarismo. (Lavar y tender su propia ropa interior, doblar la ropa, llevar el plato a la cocina, jugar con los niños, participar en la preparación de los alimentos basicos con el desayuno o la cena). - Monitoreo cercano de signos de riesgo (ideación suicida, conductas extrañas, aumento de retraimiento), con protocolo familiar de alerta y acompañamiento inmediato en caso de reactivación de síntomas psicóticos. - Alimentacion saludable libre de grasas altas y azucares. - Ejercicio físico minimo 30 minutos al día.

DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica
Tarjeta Profesional: 259542
Mag. TP3G - VIU



PRASCA
CENTER